

จริยธรรมทางการแพทย์
และกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้ดำเนินการพยาบาลเฉพาะทางฟื้นฟูสภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรานทิพย์ ฉายพุทธ

19/8/69 (13-16)

REFERENCES

- Beauchamp, T. L. & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics. (8th eds.). New York: Oxford University Press.
- Edge, R. S. & Groves, J. R. (2018). Ethics of health care: A guide for clinical practice. (4th eds.). St. Louis, MO: Delmar Cengage Learning.
- Grace, P. J. & Uveges, M. K. (2023). Nursing ethics and professional responsibility in advanced practice. (4th eds.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.

เนื้อหา

1. สาเหตุและประเด็นจริยธรรมในการพยาบาล
2. ลักษณะผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย
3. หลักจริยธรรมทฤษฎีจริยศาสตร์ และข้อบังคับจริยธรรม
4. สิทธิผู้ป่วยและการพิทักษ์สิทธิ
5. กฎหมายแพ่ง ละเมิด และกฎหมายอาญา
6. การละเมิดสิทธิผู้ป่วย การให้ความยินยอม
7. การพิทักษ์สิทธิ รูปแบบการพิทักษ์สิทธิ
8. กฎบัตรสากล กฎหมาย กฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับฟื้นฟูสภาพ
9. แบบทดสอบหลังการเรียนรู้

สาเหตุของประเด็นจริยธรรม/
สาเหตุของการฟ้องร้อง

สาเหตุของประเด็นจริยธรรมในการพยาบาล

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2. ลักษณะสังคม วัฒนธรรม และโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
3. ระบบสุขภาพ
4. กฎหมาย และการควบคุมของวิชาชีพ

(Beauchamp & Childress, 2019; Edge & Groves, 2018; Fry, Veatch & Taylor, 2011)

- ผู้รับบริการที่พึงพอใจในการบริการ จะฟ้องร้องน้อย
- การสื่อสารเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ฟ้องร้องมาก
- ความโกรธ (ANGER) เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่การบาดเจ็บ (INJURY) ที่เกิดจากความผิดพลาดในการรักษา

(Press, I., Patient Satisfaction: Defining, measuring, and improving the experience of care, Chicago, Health Administration Press, 2002, p.21)

- ความพึงพอใจที่ลดลง 1 คะแนน จะทำให้ต้องจัดการความเสี่ยงในการให้บริการที่อาจถูกฟ้องร้องเพิ่มขึ้น 5%

(Stelfox, et. al., "The relation of patient satisfaction with complaints against physicians and malpractice lawsuits", Am J Med, 2005)

เกณฑ์ในการพิจารณา

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

ผู้รับบริการ/ ทายาท/ ผู้อุปการะ/ หน่วยบริการ

ระยะเวลายื่นคำร้อง

เดิม ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564) ยื่นคำร้องภายใน 2 ปี
นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2555, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

เกณฑ์ในการพิจารณา

- ✖ เป็นผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
- ✖ เป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการในระบบ UC
- ✖ อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยของเขต เป็นผู้พิจารณา
- ✖ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน (นับแต่วันทราบผลวินิจฉัย)

ลักษณะผู้ป่วยที่อาจเกิดประเด็น

อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

ประเภทของความเสียหาย	อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ
1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต	240,000 แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
2. สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต	100,000 แต่ไม่เกิน 240,000 บาท
3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง	ไม่เกิน 100,000 บาท

*** ความเสียหายที่เกิดขึ้น ต้องไม่เกิดจากการดำเนินตามพยาธิสภาพของโรค หรือ เหตุแทรกซ้อนที่เป็นผลจากการวินิจฉัยตามปกติ หรือการรักษาโรคตามมาตรฐาน

ลักษณะผู้ป่วยที่อาจเกิดประเด็น

การเปลี่ยนแปลง/ ความบกพร่อง

1. ความสามารถ (Capacity) - การตัดสินใจ : สุขภาพจิต?
สูงอายุ?
2. ทางกาย - รูปร่าง ภาพลักษณ์ ความพิการ ทุพพลภาพ
3. ทางสรีรวิทยา - ความผิดปกติระบบประสาท การรับรู้ ประสาทสัมผัส
4. ความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ - ซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพจิต/
จิตเวช
5. ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรม - ผู้ป่วย/ ญาติ

ประเด็น/ข้อขัดแย้ง/ปัญหาจริยธรรม (Ethical/Moral Dilemma)

ตัวอย่างประเด็นจริยธรรม
สำหรับผู้ให้บริการพยาบาลเฉพาะทาง

ประเด็น/ปัญหา/ข้อขัดแย้งเชิงจริยธรรม (Ethical Dilemma)

“ทางสองแพร่ง” สภาพการณ์ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมหรือจริยธรรม ต้องตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีทางเลือกสองทาง ซึ่งทางเลือกทั้งสองทางนี้กระทำได้ โดยถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ทั้งสิ้นก็ได้ แต่จะเลือกทางหนึ่ง ต้องทิ้งอีกทาง แต่ไม่สามารถเลือกทำทั้งสองทางได้ เป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการตัดสินใจ

(Beauchamp & Childress, 2019; Edge & Groves, 2018;
Fry, Veatch & Taylor, 2011; Grace & Uveges, 2023)

ประเด็นจริยธรรม - ทัวไป

1. ทุรเวชปฏิบัติ (Malpractice) – ไม่ได้มาตรฐาน
 - ทอดทิ้งผู้ป่วย
 - Abuse – verbal vs physical
 - การสื่อสาร
2. การให้ความยินยอมโดยการบอกกล่าว (Informed consent)
 - ความสามารถ (capacity) ***
3. ผลข้างเคียงจากการรักษา (Double effects)
 - ยาที่ใช้ – Steroids, MO

(Beauchamp & Childress, 2019; Edge & Groves, 2018; Fry, Veatch & Taylor, 2011; Grace & Uveges, 2023)

ประเด็นจริยธรรม – ใครตัดสินใจ ?

1. การถอน/หยุดการรักษา
(Withdrawal of treatment)
2. การปฏิเสธการรักษา (Refusal of treatment)
3. End of life decision – คุณภาพชีวิต
4. Do not resuscitate order (DNR)

(Beauchamp & Childress, 2019; Edge & Groves, 2018; Fry, Veatch & Taylor, 2011; Grace & Uveges, 2023)

ประเด็นจริยธรรม – ใครตัดสินใจ ?

5. การตัดสินใจแทน (Substitution decision making)
6. การจัดการทรัพยากร (Resource allocation)
– ปัญหาการเงิน/นโยบายสุขภาพ/ระบบประกัน
7. จริยธรรมการวิจัย – Vulnerable group ?

(Beauchamp & Childress, 2019; Edge & Groves, 2018; Fry, Veatch & Taylor, 2011; Grace & Uveges, 2023)

Principle of Medical Ethics

1. **AUTONOMY** – The right for an individual to make his or her own choice.
2. **BENEFICENCE** – The principle of acting with the best interest of the other in mind.
3. **NON-MALEFICENCE** – The principle that “above all, do no harm,” as stated in the Hippocratic Oath.
4. **JUSTICE** – A concept that emphasizes fairness and equality among individuals.

(Beauchamp & Childress, 2019)

หลักจริยศาสตร์
Principle of Ethics

หลักจริยศาสตร์ในการพยาบาล

1. การพิทักษ์สิทธิ (Advocacy)****
2. ความเท่าเทียมกัน/ความยุติธรรม (Justice) – ความเหลื่อมล้ำ

“ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม”

Justice delayed is Justice denied

มหากฎบัตร (Magna Carta) ข้อ 40

“อันว่าสิทธิก็ดี หรือความยุติธรรมก็ดีนั้น เราจักไม่ขายให้แก่ผู้ใด
เราจักไม่เพิกเฉยหรือทำให้ล่าช้าต่อผู้ใด”

(To no one will we sell, To no one will we refuse or delay,
Right or Justice)

หลักจริยศาสตร์ในการพยาบาล

3. การไม่ทำให้เกิดอันตราย (Non-maleficence – Do no harm)
4. การทำประโยชน์หรือสิ่งดีแก่ผู้อื่น (Beneficence – Do good)
5. การเคารพในเอกสิทธิ์ (Respect for autonomy) หรือ
มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determination)
6. การบอกความจริง (Veracity – Tell the truth)
7. การรักษาความลับ (Confidentiality)

(Beauchamp & Childress, 2019; Edge & Groves, 2018; Fry, Veatch & Taylor, 2011; Grace & Uveges, 2023)

ทฤษฎีจริยศาสตร์ *Theory of Ethics*

ทฤษฎีจริยศาสตร์

- ✎ หน้าที่นิยม (Deontological/ Duty-oriented/
Nonconsequential theory)
- ✎ ประโยชน์นิยม (Utilitarianism/ Teleological/
Consequence-oriented/
Consequential theory)

(Beauchamp & Childress, 2019; Edge & Groves, 2018)

ทฤษฎีหน้าที่นิยม

(Deontological or Duty-oriented theory)

= การกระทำที่ถูกต้องเป็นการทำตามหน้าที่ที่สังคมกำหนด

ทฤษฎีประโยชน์นิยม

(Utilitarianism or Consequence-oriented theory)

= การกระทำที่ถูกต้องเกิดจากการเลือกและชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยทำให้มีผลลัพธ์ในภาพรวมดีที่สุดหรือได้ประโยชน์สูงสุด

(Beauchamp & Childress, 2019; Edge & Groves, 2018)

ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาริยธรรมฯ

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาริยธรรม แห่งวิชาชีพการพยาบาลและพดุงครรภ์ 2550, 2564

การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ให้บริการ

ข้อ 7 รักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลกำหนด โดยไม่เรียกร้อยสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ

ข้อ 8 ไม่มุ่งใจหรือชักชวนผู้ใดให้มาใช้บริการการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์เพื่อผลประโยชน์ของตน

ข้อ 9 ไม่เรียกร้อยสินรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทน เนื่องจากรับบริการทางการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาริยธรรม แห่งวิชาชีพการพยาบาลและพดุงครรภ์ 2550, 2564

การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ให้บริการ

ข้อ 10 ปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ให้บริการโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็ญ

ข้อ 11 ไม่หลอกลวงผู้ให้บริการให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของตน

ข้อ 12 ไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือผู้ให้บริการ

ฉบับบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม แห่งวิชาชีพการพยาบาลและพดุงครรภ์ 2550, 2564

การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ให้บริการ

ข้อ 15 ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก

ผู้ป่วยหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อ 16 ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะอันตราย

ข้อ 17 ไม่ประกอบวิชาชีพในที่สาธารณะ เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อ 18 ไม่สนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพโดยผิดกฎหมาย

การกล่าวหา/กล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 33

- ผู้มีสิทธิส่งเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมต่อสภาการพยาบาล
การกล่าวหา - ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ทายาทโดยธรรมของผู้ป่วย
หรือผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย
การกล่าวโทษ - กรรมการสภาการพยาบาล
- กำหนดระยะเวลาส่งข้อกล่าวหา/กล่าวโทษ
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้เรื่องการกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำ
ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่มีการประพฤติผิด

สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิผู้ป่วย

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

- องค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (the Universal Declaration of Human Rights) เมื่อปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) คัมครองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ
- องค์การสหประชาชาติประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (the United Nations Declaration on the Rights of the Child 1959) แต่ปฏิญญาไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

- มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 27, 28, 30

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

- มาตรา 55 บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
- มาตรา 80 รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

- มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
- ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560

- หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ

.....อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้

สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม...

สิทธิผู้ป่วย (Patient Rights)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
- 16 เม.ย. 2541 สภาวิชาชีพ – สภาการพยาบาล แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
- สิทธิของผู้ป่วย 10 ประการ
- 12 ส.ค. 2558 – สิทธิของผู้ป่วย 9 ประการ



ความสามารถของบุคคล

บุคคลหย่อนความสามารถในการทำนิติกรรม 3 ประเภท
และกำหนดให้มีผู้ดูแลบุคคลเหล่านี้ในการทำกรใดๆ คือ

- ✍ ผู้เยาว์ - ผู้แทนโดยชอบธรรม/ ผู้ปกครอง
- ✍ คนเสมือนไร้ความสามารถ - ผู้พิทักษ์
- ✍ คนไร้ความสามารถ - ผู้อนุบาล

กฎหมายแพ่ง ความสามารถของบุคคล ความรับผิดชอบละเมิด

ผู้เยาว์

คือ ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
พพ. กำหนดให้ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะได้คือ

1. โดยอายุ – เมื่อครบ 20 ปีบริบูรณ์
2. โดยการสมรส เมื่อผู้เยาว์อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์และทำการสมรสโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายโดยผู้แทนให้ความยินยอม หรืออายุยังไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์แต่ศาลอนุญาตให้ทำการสมรส

คนเสมือนไร้ความสามารถ

- ❖ เหตุบกพร่องทางกายคือ พิการ
- ❖ เหตุบกพร่องทางจิต-จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ แต่ไม่ถึงวิกลจริต
- ❖ ความประพฤตีสُر่ยสุร้ายเสเพลเป็นอาชญา
- ❖ ดื่มสุราจนเสพติด จนไม่สามารถจัดการงานตัวเอง หรือจัดกิจการในทางที่เสื่อมเสีย

การสิ้นสภาพบุคคล

- การถึงแก่ความตายตามธรรมชาติ
- การถึงแก่ความตายตามข้อยุติทางการแพทย์
- การถึงแก่ความตายตามคำพิพากษาหรือศาลสั่ง

ข้อสังเกต การตายตามธรรมชาติหรือตามข้อยุติทางการแพทย์ไม่อาจมีการกลับคืนของสภาพบุคคลได้อีก

คนไร้ความสามารถ****

- ✓ บุคคลที่มีเหตุบกพร่องทางจิตอย่างมากหรือวิกลจริต สติวิปลาส ต้องมีอาการเป็นประจำไม่ใช่เป็นครั้งคราว
- ✓ ผู้อนุญาตให้อำนาจจัดการงานต่างๆ แทนคนไร้ความสามารถตามที่กฎหมายกำหนด
- ✓ นิติกรรมที่บุคคลทำในขณะวิกลจริต หรือโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายรู้ว่าวิกลจริต นิติกรรมตกเป็นโมฆียะ

การตายตามข้อยุติทางการแพทย์

ประกาศแพทยสภาเรื่อง เกณฑ์การวินิจฉัยสมองตาย ประกาศ ณ 30 มิถุนายน 2532 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ 31 มีนาคม 2539 คือ บุคคลผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าสมองตาย ถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย และ

สมองตายหมายถึง การที่แกนสมองถูกทำลายจนสิ้นสุดการทำงานโดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยเมื่อแกนสมองตายหรือสมองหยุดทำงานไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม และสมองไม่สามารถกลับมาทำงานได้อีก

การตายตามข้อยุติทางการแพทย์

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2551 กำหนด “การตายของบุคคล” ว่าหมายถึง

1. บุคคลอยู่ในสภาวะที่ระบบไหลเวียนเลือด และระบบการหายใจหยุดทำงาน โดยไม่สามารถกลับคืนได้อีก **หรือ**
2. อยู่ในภาวะสมองตายคือ การที่แกนสมองถูกทำลายจนสิ้นสุดการทำงานโดยสิ้นเชิงตลอดไป

ความเสียหายที่กฎหมายรับรอง

- ต่อร่างกายโดยต่อกาย
- ต่อชีวิตโดยทำให้ถึงแก่ความตาย
- ต่ออนามัยโดยทำให้เสื่อมเสียสุขภาพหรือเดือดร้อน
- ต่อเสรีภาพโดยอาจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรืออื่นๆ
- ต่อทรัพย์สินโดยเสื่อมค่า ทำลาย ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้สิทธิที่เกินควรคาดหมาย
- ต่อสิทธิที่กฎหมายรับรอง – สิทธิครอบครอง สิทธิตามสัญญา

ความรับผิดทางละเมิด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า

“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นทำละเมิด ต้องจ่ายค่าสินไหมเพื่อทดแทนการนั้น”

ค่าสินไหมทดแทน

- การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมาย
 - ค่าสินไหมทดแทน – ตัวเงิน
 - ค่าเสียหายอันพึงบังคับใช้ – ไม่อาจตีราคาเป็นเงิน (ความทุกข์ทรมาน, ค่าทำขวัญ)
 - คืนทรัพย์สินหรือใช้ราคา
- อายุความละเมิด – 1 ปี นับแต่รู้ถึงละเมิดและผู้กระทำ
 - 10 ปี นับแต่ทำละเมิด

กฎหมายอาญา กระทำผิดโดยประมาท

วิธีการเพื่อความปลอดภัย

มาตรา 39 วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้

- (1) กักกัน
- (2) ห้ามเข้าเขตกำหนด
- (3) เรียกประกันทัณฑ์บน
- (4) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล
- (5) ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง

กฎหมายอาญา: การกระทำโดยประมาท

- ✍ กระทำโดยไม่ตั้งใจ แต่ปราศจากความระมัดระวังที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นแต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ (ไม่ได้ใช้)
- ✍ ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์
วิสัย – สภาพเกี่ยวกับตัวผู้กระทำ – ผู้ประกอบวิชาชีพ
พฤติการณ์ – เหตุภายนอกตัวผู้กระทำ – สถานที่ เวลา

การกระทำผิดโดยประมาท

กฎหมายบัญญัติให้การกระทำผิดโดยประมาทต้องรับผิดทางอาญา

1. ทำให้ผู้อื่นตาย
2. ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย
3. ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส
4. ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน
5. หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
6. ทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย – จนถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัส
7. ผู้ควบคุมบุคคลวิกลจริตปล่อยปละละเลยให้ออกเที่ยวโดยลำพัง

เหตุผลโทษ

กฎหมายกำหนดเหตุผลโทษ ได้แก่

- การป้องกันหรือจำเป็นเกินขอบเขต
- เด็กหรือเยาวชนกระทำผิด
- บันดาลโทษ
- เหตุบรรเทาโทษ
- สำคัญผิดในข้อเท็จจริง
- ลัทธิพรมีเหตุฉกรรจ์โดยความจำใจหรือยากจน

ความผิดตามกฎหมายอาญา

- ❑ ความผิดฐานปลอมเอกสาร
(แก้ไขเวชระเบียน/ ใบสั่งยา/ ใบประกอบวิชาชีพ)
- ❑ ความผิดฐานรับรองเท็จ
- ❑ ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
- ❑ ความผิดฐานงดเว้นการปฏิบัติ
- ❑ ความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้อื่น

ความผิดตามกฎหมายอาญา

- ❑ ความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยเจตนา (ความยินยอม)
- ❑ ความผิดฐานกระทำโดยประมาท (แพ้ยา/ให้น้ำเกลือผิด)
- ❑ ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (กลับบ้านไม่ให้คำแนะนำ)
- ❑ ความผิดฐานละทิ้ง/ทอดทิ้งผู้ป่วย (ตกเตียง)
- ❑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ (ไม่ให้กลับบ้านเพราะไม่มีเงินค่ารักษา)

การละเมิดสิทธิผู้ป่วย
การให้ความยินยอม

การละเมิดสิทธิผู้ป่วย

การปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วย

- สิทธิส่วนตัวเฉพาะผู้มีความสามารถ

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 มาตรา 12

“บุคคลมีสิทธิในการแสดงความจำนนที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตัวเองเพื่อการตายอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์”

การละเมิดสิทธิผู้ป่วย/การให้ความยินยอม

กระทำการพยาบาลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นการ

“ละเมิดสิทธิผู้ป่วย”

ความยินยอมต้องเป็นอัน **“บริสุทธิ์”**

การละเมิดสิทธิผู้ป่วย

การปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วย

- แพทย์ไม่สามารถละเลยผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะตายใน ขณะที่ภาวะร่างกายและ/หรือจิตใจไม่ปกติ
- ผู้ป่วยที่แสดงความจำนนล่วงหน้าขณะมีสติสัมปชัญญะ สมบูรณ์ว่าไม่ต้องยืดเวลาตายออกไป เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอน และตามหลักฐานที่มี **แพทย์หมดหน้าที่โดยไม่ถือว่าทอดทิ้ง** ผู้ป่วย แต่ พยาบาลต้องดูแลต่อเสมอ

การให้ความยินยอม (Informed consent)

องค์ประกอบของการให้ความยินยอม

- ✚ Competence – ความสามารถในการให้ความยินยอม
- ✚ Disclosure – การให้ข้อมูลที่เป็นความจริงทั้งหมดให้ทราบ (ทั้งข้อดีและข้อเสีย) โดยใช้ศิลปะการสื่อสาร
- ✚ Comprehension – เข้าใจถูกต้องตรงกันทั้งหมด
- ✚ Voluntariness – โดยสมัครใจ ไม่ถูกบังคับข่มขู่
- ✚ Consent – แสดงเจตนาให้ความยินยอมเฉพาะสิ่งที่ถูกบอกกล่าว

การให้ความยินยอม (Informed consent)

ความยินยอมที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย **

1. มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน - ไม่บกพร่องเรื่องความสามารถ
2. ผู้ให้ความยินยอมแทนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
3. ต้องรับรู้ข้อมูลเท็จจริงอย่างครบถ้วน - ข้อดีและข้อเสีย
4. เป็นความยินยอมที่บริสุทธิ์ - ปราศจากการบังคับ หลอกลวง ชูเชิญ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน เสรีภาพ ทำให้สำคัญผิด

(Edge & Groves, 2018; Fry, Veatch & Taylor, 2011; Grace & Uveges, 2023)

การพิทักษ์สิทธิ***

รูปแบบการพิทักษ์สิทธิ (Model of Nurse Advocacy)

Right-protection model

พยาบาลเป็นผู้พิทักษ์สิทธิของผู้รับบริการ (Defender of patient's right)

Value-based decision model

พยาบาลร่วมพูดคุยถึงความต้องการ (Needs) ประโยชน์ (Interests) และทางเลือก (Choices) ของผู้รับบริการ

Respect-for-person model

พยาบาลเคารพลักษณะพื้นฐานของผู้รับบริการ - ความมีศักดิ์ศรี (Dignity) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และประโยชน์สาธารณะ (Welfare)

(Fry, Veatch & Taylor, 2011; Grace & Uveges, 2023)

การพิทักษ์สิทธิ:

รูปแบบการพิทักษ์สิทธิ

(Model of Nurse Advocacy)

การตัดสินใจเชิงจริยธรรม

(Ethical Decision Making Model)

การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making Model)

แนวปฏิบัติในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมรายกรณี
(Approach for Case-based Ethical Decision-making)

<u>Medical Factors</u> Diagnosis Treatment Prognosis	<u>Preferences</u> Patient Family Team
<u>Quality of Life</u> Before During After	<u>Context</u> Support system Cost, Availability Special circumstance

(McKneally & Singer, 2001)

กฎบัตรสากล กฎหมาย กฎ และข้อบังคับ เกี่ยวกับผู้พิการและการฟื้นฟูสภาพ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

- ❑ พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
- ❑ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- ❑ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
- ❑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
- ❑ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- ❑ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

กฎบัตรสากล กฎหมาย และสิทธิที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(The universal declaration of human rights)
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(Convention on the rights of persons with disabilities: CRPD)
- ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย – พ.ศ. 2541
ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540

ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. 2552
- ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2537 ออกตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

- เงินเบี้ยความพิการให้อัตราเดือนละ 500 บาทหรือตามมติกรม. (พ.ศ.2553)
- มติกรม. (พ.ย.2557) ปรับตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 800 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่ค.ศ.2558
- มติกรม. (ม.ค.2563) ปรับเบี้ยเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค.ศ. 2563

พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534

มาตรา 15 (ต่อ)

- (3) คำแนะนำชี้แจง และปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพของร่างกาย และสมรรถภาพที่มีอยู่เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้
- (4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ
- (5) บริการจากรัฐ ในการเป็นคดีความและในการติดต่อกับทางราชการ

พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534

มาตรา 15 คนพิการที่ลงทะเบียนตามมาตรา 14 ให้ได้รับการสงเคราะห์ การพัฒนาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดังต่อไปนี้

- (1) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (2) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสม..... ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2537)

ออกตามพรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534

ข้อ 1 ให้คนพิการที่ลงทะเบียนตามมาตรา 14 ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

- (1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่นๆ
- (2) การให้คำแนะนำปรึกษา (3) การให้ยา (4) การศัลยกรรม
- (5) การพยาบาลเวชกรรมฟื้นฟู (6) กายภาพบำบัด
- (7) กิจกรรมบำบัด (อาชีพบำบัด) (8) พฤติกรรมบำบัด (9) จิตบำบัด
- (10) สังคมสงเคราะห์ และสังคมบำบัด (11) การแก้ไขการพูด (อรรถบำบัด)
- (12) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน และการสื่อความหมาย
- (13) การให้อุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยคนพิการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม

พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550

- มาตรา 19 บัตรประจำตัวคนพิการ
(มาตรา 41 ให้ถือว่าบัตรประจำตัวคนพิการตามพรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534 เป็นบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19)
- มาตรา 37 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2556

- พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
- กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีฐานะเป็นกรม และกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และการอำนวยความสะดวก
- กำหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริการ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550

- มาตรา 33 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม
- มาตรา 38 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าทำงานมากกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้าง โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่า 180 วันในปีภาษีใด มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น ตามที่กฎหมายกำหนด

ประเภทของความพิการ

1. ความพิการทางการเห็น
2. ความพิการทางการได้ยิน
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหว
4. ความพิการทางการสื่อสาร
5. ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม
6. ความพิการทางสติปัญญา
7. ความพิการทางการเรียนรู้

ประเภทของความพิการ

ประกาศ ศธ. เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคณพิการทางการศึกษา และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2552 กำหนดประเภทคณพิการ 9 ประเภท คือ

1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565)
3. ทางสติปัญญา
4. ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
5. ทางการเรียนรู้
6. ทางการพูด และภาษา
7. ทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
8. ออทิสติก
9. พิการซ้อน

หน้า ๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่

(๑) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม ในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ อัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการทำางาน มือ เท้า แขน ขา

(๒) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม ในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลำตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน

คณพิการ

ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

[ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคง ของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (3) และประกาศแนบท้ายเรื่องแบบและ รายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ พ.ศ. 2552 ข้อ 3]

- ☐ แขนขาดตั้งแต่ระดับข้อมือขึ้นไป อย่างน้อย 1 ข้าง
- ☐ ขาขาดตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นไป อย่างน้อย 1 ข้าง

หน้า ๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ ที่ระบุประเภทความพิการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ เพื่อประกอบคำขอมีบัตร ประจำตัวคณพิการตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เว้นแต่นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณี เห็นว่าบุคคลนั้นมีสภาพ ความพิการที่สามารถมองเห็นได้โดยประจักษ์จะไม่ต้องให้มีการตรวจวินิจฉัยก็ได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

- ❖ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้จ่ายอัตราเดือนละ 500 บาทหรือ **ตามมติคณะรัฐมนตรี** (พ.ศ. 2553)
- ❖ มติครม. (พย. 2557) ปรับตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพิ่มเบี้ยความพิการจากเดิม 500 บาท เป็น 800 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่ ต.ค. 2558
- ❖ มติครม. (มค. 2563) ปรับเบี้ยความพิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ ต.ค. 2563

- ☐ อย่าลืมเรื่องการสื่อสารที่ดี
(Good communication is a vital key !!!!)
- ☐ รับผิดชอบต่อความต้องการและข้อจำกัดของผู้ป่วยและครอบครัว
- ☐ ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นับถือการตัดสินใจบนพื้นฐานความเข้าใจ ทางเลือก และข้อมูลที่เพียงพอ
- ☐ บันทึกการพยาบาลที่ถูกต้อง ครอบคลุมสาระสำคัญเข้าใจง่าย

สรุปประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย

1. ความสามารถของผู้ป่วย
2. ผู้แทน
3. สิทธิผู้ป่วย VS การพิทักษ์สิทธิ
4. มาตรฐานการพยาบาล

- ☐ หลักจริยธรรม – First, do no harm
- ☐ Patient Advocacy

- ☐ Patient Safety

“ผู้ป่วยปลอดภัย เราปลอดภัย”

ดำตามต๊ะ?

แบบทดสอบหลังเรียน